UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

instituto de ciências farmacêuticas
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Macaé

LUIZA NUNES MARINHO

FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL: PANORAMA, DESAFIOS E REFLEXÕES (2019-2022)

MACAÉ

2024

LUIZA NUNES MARINHO

FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL: PANORAMA, DESAFIOS E REFLEXÕES (2019-2022)

Trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado ao Curso de Farmácia do Instituto de Ciências Farmacêuticas da UFRJ, como requisito para obtenção do título de farmacêutico.

Orientadora: Profa. Dra. Isabella Piassi Dias Godói

MACAÉ

2024

CIP - Catalogação na Publicação

M338f

Marinho, Luiza Nunes
FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL: PANORAMA, DESAFIOS E REFLEXÕES (2019-2022) / Luiza Nunes Marinho. -- Rio de Janeiro, 2024.
50 f.

Orientadora: Isabella Piassi Dias Godói.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Farmacêuticas, Bacharel em Farmácia, 2024.

1. Financiamento da Saúde. 2. Sistema Único de Saúde . 3. Gestão. 4. Saúde Pública. I. Godói, Isabella Piassi Dias, orient. II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

LUIZA NUNES MARINHO

FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL: PANORAMA, DESAFIOS E REFLEXÕES (2019-2022)

Trabalho de conclusão de curso (TCC) defendido e aprovado como requisito para obtenção do título de farmacêutico.

Macaé, 22 de Outubro de 2024.

Comissão avaliadora:

Profa. Dra. Isabella Piassi Dias Godói (Presidente da Banca)

CM UFRJ-Macaé
http://lattes.cnpq.br/9235375090080643

Profa. Me. Rebeca Reis e Silva

CM UFRJ-Macaé
link lattes

Profa. Dra. Isabela Barboza da Silva Tavares Amaral

CM UFRJ-Macaé
Link lattes

Agradecimentos

Primeiramente, agradeço a Deus, por ser minha força e guia em todos os momentos. Sua presença constante me deu coragem e sabedoria para superar os desafios e alcançar meus objetivos. Toda a minha gratidão é para Ele, que nunca me deixou desistir e que, desde antes do início da minha trajetória acadêmica, colocou em minha vida pessoas excepcionais, que me impulsionaram e me deram suporte ao longo da minha caminhada.

Ao meu pai Raphael, por todo o apoio e amor incondicional. E, especialmente, à minha mãe Vívian, que, apesar de todas as dificuldades, sempre fez o possível e o impossível para que eu chegasse até aqui. Seu esforço, dedicação e amor são a razão de eu estar onde estou hoje. Tudo o que conquistei e tudo o que ainda conquistarei será sempre por você.

À minha irmã Maitê, por ser minha companheira e amiga. Agradeço por cada momento que passamos juntas, pelas risadas e pelo apoio. Você é uma luz na minha vida e meu amor por você é incondicional.

À minha avó, Alsenir, por ser um exemplo de força e dedicação. Apesar de todas as dificuldades, sempre fez de tudo para me ajudar e para que eu pudesse conquistar meus sonhos. Sua generosidade, amor e apoio incondicional foram fundamentais para que eu chegasse até aqui. Sou eternamente grata por tudo que fez por mim.

À minha "neném", Aparecida, por ter sido minha maior aliada na difícil tarefa de convencer minha mãe a me deixar ir morar em uma cidade distante. Sua confiança em mim e seu apoio constante foram fundamentais para que eu pudesse seguir meus sonhos. Sou eternamente grata por tudo que fez por mim.

Ao meu namorado, Gabriel, por ser meu porto seguro e meu maior incentivador. Seu amor e sua confiança em mim me deram forças para seguir em frente e alcançar meus objetivos.
Agradeço também à sua família, por sempre me acolher de braços abertos e pelo apoio durante o período em que precisei fazer meus estágios. Guardarei para sempre no coração todo o carinho e suporte que recebi de vocês.

Aos meus amigos da faculdade, Luiza Leite, Vinícius Tavares, Marcelly Mello, Dayse Silva, Fernanda Mata, Sávio Magalhães, Sávio Greenwood, Geovanna Lopes, Vitória Lessa, Gabriele Cardoso e Hellena Bastos, por toda a parceria, risadas, choros compartilhados e apoio incondicional. Vocês foram meu refúgio e minha segunda família ao longo desses cinco anos de graduação. Levarei todos vocês no meu coração, onde quer que eu vá.

À minha orientadora, Professora Dra. Isabella Godói, por quem tenho imensa admiração e gratidão. Seu amor pelo SUS e pelo magistério me fizeram admirá-la ainda mais e poder tê-la como orientadora nessa etapa tão importante é muito gratificante. Obrigada por cada ensinamento e por toda confiança depositada em mim.

À todos os professores que fizeram parte da minha formação e a todos os profissionais que encontrei ao longo dos meus estágios, por compartilharem seus valiosos ensinamentos e vivências. Cada um de vocês contribuiu para o meu crescimento profissional e pessoal. Sou grata pelo apoio, orientação e pela oportunidade de aprender com pessoas tão dedicadas e talentosas.

"A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.".(Hebreus 11:11)

RESUMO

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) tem se estabelecido como uma importante política pública de saúde, com foco na promoção da oferta de serviços em diferentes complexidades à população de forma gratuita. Um dos muitos desafios é o financiamento da saúde pública no Brasil, uma vez que apresenta crescentes demandas e um orçamento limitado, o que reforça a realização de estudos que visem discutir e entender esta temática. **Objetivo**: Apresentar o valor global destinado aos serviços públicos de saúde, na perspectiva do SUS, no período entre 2019 e 2022, advindos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), bem como um detalhamento para cada bloco de financiamento. **Métodos:** Estudo quantitativo descritivo, desenvolvido no primeiro semestre de 2024, a partir da extração de dados do período de 2019 a 2022 disponíveis no portal do FNS referente aos recursos destinados à saúde pública no Brasil para os diferentes blocos de financiamento. Além disso, foram utilizados dados abertos disponibilizados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD). Foram realizadas tabulações e gráficos no intuito de melhor avaliar e compreender os dados obtidos. Adicionalmente, foram utilizados dados extraídos do IBGE e relatórios disponíveis no site do governo como o Plano Plurianual (PPA) e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO). **Resultados e discussão:** A partir dos resultados obtidos, no FNS, verificou-se que os recursos destinados à área da saúde no Brasil, no período de 2019 a 2022, foram de R$406.283.635.920,00 e observa-se a considerável diferença orçamentária aplicada ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta complexidade, que comprometeu 59,32% dos recursos destinados à saúde. Os demais blocos como Atenção Primária (27,72%), Vigilância em Saúde (2,98%) e Assistência Farmacêutica (1,81%) representaram um percentual muito inferior quando comparado com as ações e serviços do bloco da Atenção de Média e Alta complexidade. No cenário da Assistência Farmacêutica foram destinados R$7.292.786.156,95 e não foi possível uma compreensão detalhada de todas as ações em saúde envolvidas dentro deste bloco. Observa-se uma discrepância entre o perfil de recursos alocados a cada bloco, em especial, com uma maior quantia destinada à Atenção Especializada. Destaca-se ainda que, neste período, tivemos a pandemia COVID-19 e serviços como o Programa Nacional de Imunização e a Estruturação de unidades de Atenção Especializada em saúde, que foram amplamente utilizadas, o que pode ter influenciado em uma maior demanda nestas áreas. Conclusão: Este estudo identificou algumas fragilidades, como a falta de transparência nos dados financeiros do setor de assistência farmacêutica e o

baixo investimento na Atenção Primária, área primordial para garantir o acesso universal e equitativo aos serviços de saúde, além de ser fundamental para promover o bem-estar e a qualidade de vida da população brasileira. Com isso, reforça-se a necessidade de mais estudos e avaliações que promovam as análises e compreensão do perfil da alocação de recursos em saúde para os diferentes níveis de gestão, com foco na eficiência e sustentabilidade financeira do SUS.
Palavras-Chave: Financiamento da Saúde; Sistema Único de Saúde; Gestão; Saúde Pública.

ABSTRACT

Introduction: The Unified Health System (SUS) has established itself as an important public health policy, focusing on promoting the provision of services in different complexities to the population free of charge. One of the many challenges is the financing of public health in Brazil, since it presents growing demands and a limited budget, which reinforces the realization of studies aimed at discussing and understanding this theme. Objective: To present the global amount allocated to public health services, from the perspective of the SUS, in the period between 2019 and 2022, from the National Health Fund (FNS), as well as a breakdown for each block of funding. Methods: A quantitative descriptive study, developed in the first half of 2024, based on the extraction of data from the period 2019 to 2022 available on the FNS portal regarding the resources allocated to public health in Brazil for the different financing blocks. In addition, open data made available by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) were used. Tabulations and graphs were made in order to better evaluate and understand the data obtained. In addition, data extracted from the IBGE and reports available on the government's website were used, such as the Multi-Year Plan (PPA) and the Summary Report of Budget Execution (RREO). Results and discussion: Based on the results obtained in the FNS, it was found that the resources allocated to the health area in Brazil, in the period from 2019 to 2022, were R$406,283,635,920.00 and the considerable budget difference applied to the Specialized Care financing block is observed, which committed 59.32% of the resources allocated to health. The other blocks, such as Primary Care (27.72%), Health Surveillance (2.98%) and Pharmaceutical Services (1.81%), represented a much lower percentage when compared to the actions and services of the Specialized Care block. In the scenario of Pharmaceutical Services, R$7,292,786,156.95 was allocated and it was not possible to have a detailed understanding of all the health actions involved within this block. There is a discrepancy between the profile of resources allocated to each block, in particular, with a greater amount allocated to Specialized Care. It is also noteworthy that, in this period, we had the COVID-19 pandemic and services such as the National Immunization Program and the Structuring of Specialized Health Care units, which were widely used, which may have influenced a greater demand in these areas. Conclusion: This study identified some weaknesses, such as the lack of transparency in the financial data of the pharmaceutical services sector and the low investment in Primary Care, a key area to ensure universal and equitable access to health services, in addition to being fundamental to promote the well-being and quality of life of the Brazilian population. With this, the need for

more studies and evaluations that promote the analysis and understanding of the profile of the allocation of health resources for the different levels of management, with a focus on the efficiency and financial sustainability of the SUS.
Keywords: Health financing; Unified Health System; Management; Public Health

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Transferência de recursos públicos destinados à Atenção Primária (2019-2022) no Brasil….....25
Figura 2. Transferência de recursos públicos destinados à Assistência Farmacêutica por região do Brasil (2019-2022).....26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Detalhamento global dos recursos transferidos para os blocos de Custeio e Investimento nos anos de 2019 a 2022. 24

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Transferência de recursos públicos, advindos do FNS para o bloco de Custeio das ações em saúde no Brasil (2019-2022). 28
Quadro 2. Transferência de Recursos para a área de Assistência Farmacêutica no Brasil no período de 2019 a 2022, advindas do FNS, e associados ao Bloco de Custeio… 30
Quadro 3. Ações do Bloco de Custeio direcionadas às ações de Média e Alta Complexidade, advindos do FNS, no período de 2019 a 2022 no Brasil…..... 32
Quadro 4. Recursos destinados à Atenção Especializada, advindos do FNS, no Bloco de Custeio no período de 2019 a 2022 no Brasil… 33
Quadro 5. Transferência de recursos públicos para a saúde no Brasil entre 2019 e 2022 no Bloco de Investimento do SUS advindos do FNS. 34
Quadro 6. Ações do Bloco de Investimento, advindos do FNS, direcionadas à Atenção Especializada no período de 2019 a 2022 no Brasil… 36

LISTA DE ABREVIAÇÕES

APS	Atenção Primária à Saúde
ASPS	Ações e Serviços Públicos de Saúde
FNS	Fundo Nacional de Saúde
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
MAC	Média e Alta Complexidade
MS	Ministério da Saúde
PIB	Produto Interno Bruto
PNI	Programa Nacional de Imunização
SNT	Sistema Nacional de Transplantes
SUS	Sistema Único de Saúde
UTI	Unidade de Tratamento Intensiva

SUMÁRIO

1. Introdução… 15
2. Objetivos… 19
2.1. Objetivo geral…..... 19
2.2. Objetivos específicos…..... 19
3. Métodos..... 20
3.1. Tipo de Estudo e Período… 20
3.2. Coleta de dados… 20
3.3. Análise de dados… 22
4. Resultados..... 23
4.1 Financiamento dos serviços públicos em saúde no Brasil no período de 2019 a 2022…..... 23
4.2. Distribuição e perfil de alocação dos recursos públicos no Brasil associados ao Custeio das ações em saúde… 27
4.3. Distribuição e perfil de alocação dos recursos públicos no Brasil associados ao Investimento das ações em saúde…..... 33
5. Discussão..... 37
6. Considerações Finais 42
7. Referências..... 43

1. INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um marco importante para o cidadão brasileiro e foi institucionalizado a partir das chamadas Leis Orgânicas da Saúde nº 8080 (Brasil, 1990a) e nº 8142 de 1990 (Brasil, 1990b), com foco na promoção de diversos serviços e ações em saúde, de forma gratuita e universal aos mais de 200 milhões de habitantes do país. Dentre os seus princípios destacam-se a equidade, integralidade e a participação social, sendo o SUS o principal provedor de atenção à saúde da população brasileira (Garcia, 2020). Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos anos de 2019 a 2021, o percentual de brasileiros beneficiários de planos de saúde era de apenas 22% (ANS, 2024), o que reforça a importância deste sistema na oferta de serviços a maior parte da população. Ressalta-se que o brasileiro mesmo tendo o direito de ter o acesso aos serviços públicos em saúde, também pode, caso deseje, adquirir um plano privado de saúde a partir da compra seja individual e/ou coletiva (disponibilizado a trabalhadores de algumas empresas) (Souza et al., 2024).

Diversos são os serviços ofertados à comunidade pelo SUS, que envolvem desde a Atenção Primária à Saúde (APS), com serviços como a vacinação, até procedimentos de Alta Complexidade como a realização de transplantes, sendo o SUS responsável pela realização de cerca de 90% destes no país (Brasil, 2022). Considerada uma das principais ações de saúde pública do país, a vacinação se destaca como um serviço essencial e estratégico para a população brasileira. Segundo o Instituto Butantan (2023), desde a criação do Programa Nacional de Imunização (PNI), na década de 1970, a mortalidade infantil por doenças imunopreveníveis caiu drasticamente, o qual no início deste programa a cada 1.000 nascidos vivos, 100 morriam em decorrência de agravos infecciosos. Atualmente, são ofertados à população (crianças, adultos e idosos) mais de 40 imunobiológicos, contemplados no Calendário Nacional de Vacinação (Brasil, 2024). No período da pandemia, entre 22 de janeiro de 2020 a 10 de março de 2023, foram distribuídas mais de 500 milhões de doses, o que impactou em cerca de 38 milhões de reais (USD 7.0430868.284,85) para o orçamento público destinados à vacinação no Brasil (Brasil, 2022; Johns Hopkins University, 2024). Ressalta-se que a APS é a principal porta de entrada dos usuários no SUS, e responsável por ofertar à comunidade serviços direcionados à prevenção, promoção e recuperação da saúde (Brasil, 1990a; Bortoli et al., 2023).

Segundo a lei nº 8.142 de 1990, a participação social é reconhecida como uma importante premissa do SUS, tendo sido fundamental ao processo de construção, bem como para a consolidação desse complexo sistema público de saúde (Brasil, 1990b). Com isso, torna-se essencial o desenvolvimento de ferramentas e estratégias que possibilitem o rastreamento e transparência de informações, em especial, direcionadas à alocação dos recursos públicos em saúde, a fim de possibilitar aos gestores e ao cidadão (controle social) a rastreabilidade e, principalmente, a compreensão da aplicação do recurso público, que deve focar em melhor atender as demandas de sua população. Dentre essas ferramentas, destaca-se o Fundo Nacional de Saúde (FNS), que viabiliza a transparência na prestação de contas que envolvem os recursos públicos e busca desenvolver e disponibilizar informações para toda a sociedade relativas ao custeio, os investimentos e financiamentos no âmbito do SUS, a partir de um site de acesso gratuito e aberto a toda comunidade (FNS, 2024). No cenário do Financiamento dos serviços públicos em saúde no Brasil, até dezembro de 2017 a alocação dos recursos era organizada a partir de seis blocos de financiamento (Atenção Primária, Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão do SUS e Investimentos na Rede de Serviços de Saúde), estabelecido pela Portaria GM/MS n. 204, de 29 de janeiro de 2007. (Brasil, 2007). A partir da Portaria 3.992 de 2017, estes blocos reduziram de seis para dois, sendo estes o Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, responsável pela manutenção das ações e serviços públicos de saúde já implantados, e o Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, responsável pelos recursos destinados à estruturação e à ampliação da oferta de ações e serviços públicos de saúde (Brasil, 2017; IPEA, 2018; Pereira, 2019).

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que o Brasil possui, aproximadamente, 203 milhões de habitantes, conforme o último censo realizado em 2022 (IBGE, 2023). Adicionalmente, apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,754 (UNDP, 2021) e possui 26 estados mais o Distrito Federal, distribuídos em cinco regiões, cada uma com sua particularidade socioeconômica e cultural (IBGE, 2023). O último PIB registrado do Brasil foi de, aproximadamente, 11 trilhões de reais no ano de 2023, o que representou um crescimento de valores anteriormente apresentado (IBGE, 2023),. Aspecto este associado, em especial, com a redução dos impactos e desdobramentos para a economia brasileira da pandemia de SARS-*CoV-2,* bem como do aumento das exportações feitas pelo agronegócio, principalmente, no ano de 2022, que cresceu 32,3% comparado ao ano de 2021 (Brasil, 2022).

Ressalta-se que o Brasil, infelizmente, foi destaque dentre os países com maior impacto social durante a pandemia de SARS-*CoV-2*, com mais de 699 mil óbitos registrados e, aproximadamente, 37 milhões de casos confirmados,ocupando a 4ª posição dentre os países com mais mortes *per capita,* por 100 mil habitantes. (Johns Hopkins University, 2024). Muitos foram os desafios e demandas para os serviços públicos de saúde, o que refletiu para o aumento dos gastos do SUS, em especial, envolvendo a maior demanda por serviços da média e alta complexidade em saúde associado, por exemplo, com internações em Unidades de Terapia Intensivas e de tratamentos especializados. Segundo Castro et al. (2019), o SUS enfrentou um aumento significativo dos serviços de alta complexidade, especialmente, durante a pandemia de COVID-19, o que limitou ainda mais os recursos financeiros disponíveis. Além disso, Servo e colaboradores (2021) destacam que o financiamento do SUS precisou ser reconfigurado para atender às novas necessidades emergentes, incluindo a ampliação de leitos de UTI e a aquisição de equipamentos médicos essenciais.

Considerando a disponibilidade de instrumentos como bancos de dados como o Fundo Nacional de Saúde (FNS, 2024), bem como o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) (SIOPS, 2024), que viabilizam o acesso gratuito à informações como as transferências de recursos públicos destinados às diferentes áreas de serviço, são observados poucas publicações nesta temática, em especial, envolvendo todo o período da pandemia de SARS-*CoV-2*. Alguns estudos tem sido divulgados envolvendo o cenário brasileiro aplicados à esfera federal (Soares, 2014; Funcia et al., 2022; Coelho, 2019; Scavazza, 2022), estadual (Viana et al., 2024; Santos, 2023; Cardoso, 2017) e municipal (Silos, 2024; Morimoto, 2019; Ferreira, 2023; França, 2022), e ao cenário internacional direcionado ao panorama da gestão dos recursos públicos de saúde em países como Canadá (Marchildon, 2020) e Reino Unido (Charlesworth, 2021; Anderson, et al., 2022). Ressalta-se a relevância do entendimento sobre o perfil da distribuição da alocação dos recursos públicos em saúde, em especial, para um país continental como o Brasil e envolvendo um período que tanto desafiou e impactou para a saúde pública no cenário mundial.

A partir do exposto, o presente estudo tem dentre seus objetivos apresentar o panorama e perfil da alocação dos recursos públicos aplicados à saúde no Brasil, no período entre 2019 e 2022, que contemplou a pandemia por *SARS-CoV-2.* Adicionalmente, busca-se contribuir com as discussões sobre a transferência de recursos para as diferentes áreas da saúde, envolvendo os dois blocos de financiamento do SUS, incluindo os serviços públicos

farmacêuticos e, principalmente, as reflexões e desdobramentos do que tem sido adotado no país, marcado pela inúmeras fragilidades e demandas sociais e restrições orçamentárias.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GERAIS

Apresentar o panorama da alocação de recursos em saúde do Brasil, no período entre 2019 a 2022.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Demonstrar o perfil de alocação por cada bloco de financiamento em saúde;
- Demonstrar a relevância da utilização de bancos de dados em saúde para proporcionar à população informações em suas diversas abrangências;
- Contribuir para o levantamento de evidências sobre o contexto do financiamento público das ações em saúde no Brasil, bem como desafios e reflexões sobre esta temática.

3. MÉTODOS

3.1 Tipo de Estudo e período

Trata-se de um estudo quantitativo descritivo, realizada ao longo do ano de 2024, direcionado para melhor demonstrar o panorama e distribuição da transferência dos recursos públicos em saúde, no período de 2019 a 2022, no Brasil, advindos do FNS.

3.2 Coleta de dados

A partir da plataforma do FNS (Acesso: https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada) foram extraídos os valores anuais e totais referente aos repasses os blocos de financiamento do SUS, sendo estes o de Custeio e Investimento envolvendo o período do estudo (FNS, 2024). Esse processo envolveu a análise das transferências de recursos financeiros entre fundos dos diferentes níveis governamentais. Para isso, foi acessado o site do FNS, em seguida, na página inicial foi selecionada a opção “Consulta e Repasses”, depois “Consulta de Pagamento Consolidado”. Para este estudo, os anos selecionados foram 2019, 2020, 2021 e 2022. Para conseguir os dados completos, o procedimento precisou ser repetido para cada estado e para cada ano de interesse. Estes dados foram utilizados para análise comparativa e consolidação das informações de repasses financeiros realizados pelo FNS.

Além disso, foram rastreados o perfil de distribuição da alocação dos recursos públicos cada para um dos blocos anteriormente mencionados, que incluiu as áreas de Assistência Farmacêutica, Atenção Especializada, Atenção Primária, Vigilância em Saúde, CO VID-19, Gestão do SUS, Atenção de Média e Alta Complexidade. Ressalta-se que para as áreas de Atenção Primária, Vigilância em Saúde, COVID-19 e Gestão do SUS foram obtidos os valores gerais registrados associados aos respectivos blocos de custeio e investimento referente aos dados anuais e para o período do estudo, enquanto que Atenção Especializada, Média e Alta Complexidade e Assistência Farmacêutica foram rastreados todos os itens disponibilizados na plataforma do FNS.

Destaca-se que no cenário da Atenção Especializada foram registrados todos os recursos destinados à serviços como o Apoio à implementação da Rede Cegonha e a Implementação de políticas de atenção especializada à saúde, disponibilizado na plataforma do FNS. Adicionalmente, foram rastreados um detalhamento da alocação de recursos envolvendo a área da Média e Alta Complexidade, os quais foram encontrados registros envolvendo ações e serviços como Apoio a manutenção de unidades de saúde; Atenção à saúde da população para procedimentos de Média e Alta Complexidade; Estruturação da Atenção Especializada em Saúde Mental; Implementação da Regulação; Controle e Avaliação da Atenção à Saúde, Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para cumprimento das metas nacional; Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes e no Enfrentamento da emergência de saúde.

Neste mesmo intuito, foram coletados as ações e seus respectivos valores associados à área de Assistência Farmacêutica, incluindo Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde; Organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS; Apoio financeiro para aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e Apoio ao uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS. Para a APS foram também verificadas as ações envolvidas e disponibilizadas no FNS, direcionados aos blocos de custeio e investimento, sendo elas: Piso da Atenção Primária, Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços em Saúde para Cumprimento das Metas (Nacional), Estruturação da Rede de Serviços de Saúde, Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde, Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde, Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estruturação de Academias de Saúde (emenda), Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde, Implementação de Políticas de Atenção Especializada à Saúde, Programa de Prevenção, Controle e Tratamento de Doenças Negligenciadas, Expansão e Consolidação da Atenção Primária, Implementação de Políticas de Promoção (Nacional) e Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde.

Além dos dados disponibilizados no FNS, foram consultados os instrumentos regulatórios como o Plano Plurianual (2020-2023) (Brasil, 2024) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (2020) (Brasil, 2020), e podem ser obtidos em sites oficiais do governo

brasileiro. Foram consultadas ações realizadas com os recursos financeiros adicionais autorizados pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 (FNS, 2024).

3.3 Análise de Dados

As análises incluirão o perfil e distribuição dos recursos públicos em saúde para cada um de seus blocos de financiamento (Custeio e Investimento), bem como o detalhamento envolvendo algumas áreas contempladas nos blocos mencionados como a Assistência Farmacêutica, Atenção Especializada e Média e Alta Complexidade. Além disso, foram realizadas as distribuições de frequências absolutas e relativas, utilizando Excel 2010 .Para fins de comparação, adotamos o valor de conversão estabelecido pelo Banco Mundial para Paridades de Poder de Compra (PPPs) (2021: 1 USD 1 = 5,394763 BRL), (Banco Mundial, 2021).

4. RESULTADOS

4.1 Financiamento dos serviços públicos em saúde no Brasil no período de 2019 a 2022.

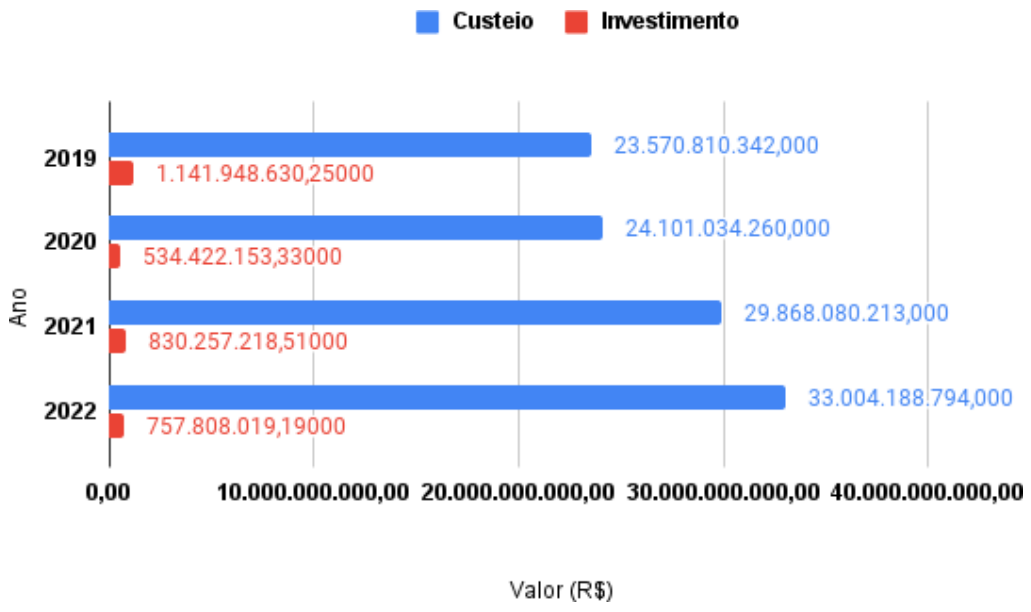
A partir dos dados advindos do FNS, verificou-se que no período entre 2019 e 2022 foram destinados ao SUS, o valor de 406.283.635.920,00 BRL (USD 75,310,747,834.52) sendo, 398.833.579.769 BRL (USD 73,929,768,512.3) para o bloco de Custeio e 7.450.056.151,25 BRL (USD 1,380,979,322.21) para o bloco de Investimento. Observa-se o perfil de distribuição e impacto ao orçamento envolvendo apenas o bloco de custeio, que representou quase a totalidade (98,2%) dos recursos públicos para este período no Brasil. A tabela 1 demonstra o perfil das transferências de recursos para cada um destes blocos para cada ano, bem como para o período avaliado.

Tabela 1: Detalhamento global dos recursos transferidos para os blocos de Custeio e Investimento nos anos de (2019 – 2022)

Ano	Custeio	%	Investimento	%	Total	%
2019	83.009.332.094	20,8	1.585.984.204	21,3	84.595.316.298 BRL USD 15,681,006,987	20,8
2020	112.235.791.852	28,1	2.954.678.584	39,6	115.190.470.437 BRL USD 21,352,276,353	28,4
2021	103.850.625.286	26	1.540.779.920	20,7	105.391.405.206 BRL USD 19,535,873,069	25,9
2022	99.737.830.536	25,1	1.368.613.441	18,4	101.106.443.977 BRL USD 18,741,591,424	24,9
Total	398.833.579.769 BRL USD 73,929,768,512	100	7.450.056.151 BRL USD 1,380,979,322	100	406.283.635.921 BRL USD 75,310,747,834	100
%	98,2		1,8		100	

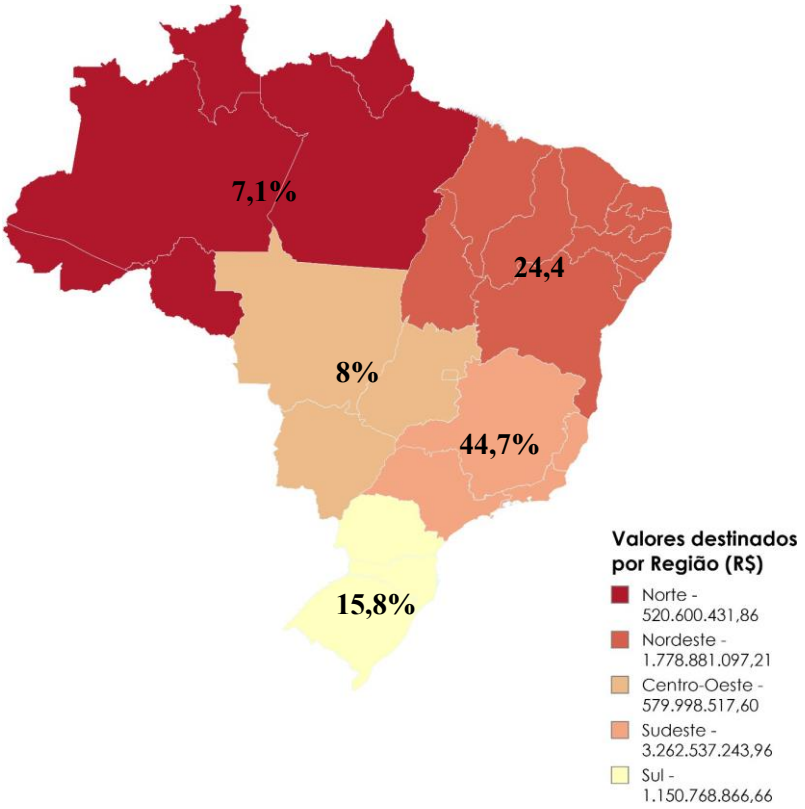
Em relação aos recursos destinados às ações da APS, envolvendo os blocos de Custeio e Investimento, durante o período de 2019 a 2022, os recursos foram distribuídos da seguinte forma: Piso da Atenção Primária (75%), Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde para Cumprimento das Metas (Nacional) (21%) e a Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde (3%), totalizando aproximadamente, 99% do montante total. O restante (1%), ficou dividido em outras como Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde (0,33%), Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde (0,16%), Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (0,08%), Estruturação de Academias de Saúde (0,08%), Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (0,18%), Implementação de Políticas de Atenção Especializada à Saúde (0,16%), o Programa de Prevenção, Controle e Tratamento de Doenças Negligenciadas na Atenção Primária (0,05%), Expansão e Consolidação da Atenção Primária (0,02%), assim como a Implementação de Políticas de Promoção 0,02% e a Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (0,05%). A figura 1 demonstra o panorama dos recursos destinados à Atenção Primária a Saúde, advindos do FNS para o período de 2019 a 2022, considerando os blocos de Custeio.

Figura 1: Transferência de recursos públicos destinados à Atenção Primária (2019-2022) no Brasil



A partir da Figura 2 pode-se observar uma disparidade nos valores repassados pelo FNS para a área da Assistência Farmacêutica em cada uma das cinco regiões do Brasil, envolvendo os recursos advindos do FNS, sendo esta uma das áreas contempladas nos Blocos de Custeio e Investimento. Observa-se a distinção do perfil de transferência de recursos entre as regiões Norte (520.600.431,86 BRL/USD 96,501,075.55; 7,1%), Nordeste (1.778.881.097,21 BRL/USD 329,742,214.29; 24,4%), Sul (1.150.768.866,66 BRL/USD 213,312,219.02; 15,8%), Sudeste (3.262.537.243,96 BRL/USD 604,760,068.97; 44,7%) e Centro-Oeste (579.998.517,60 BRL/USD 107,511,399.03; 8%).

Figura 2: Transferência de recursos públicos destinados à Assistência Farmacêutica por região do Brasil (2019-2022)



4.2 Distribuição e perfil de alocação dos recursos públicos no Brasil associados ao Custeio das ações em saúde (2019-2022)

O quadro 1 apresenta os valores repassados pelo FNS para cada uma das áreas de financiamento aplicados, ao bloco de Custeio, durante o período deste estudo. Entre esses valores, destacam-se 7.234.767.225,00 BRL (USD 1,341,072,300.11) e 110.544.113.612,00 (20,491,004,630.23 USD) destinados à Assistência Farmacêutica e à APS, respectivamente.

Quadro 1: Transferência de recursos públicos, advindos do FNS para o bloco de Custeio das ações em saúde no Brasil (2019-2022)

Ano	Assistência farmacêutica	Atenção de média e alta complexidade	Atenção especializada	Atenção primária	Gestão do SUS	Vigilância em saúde	COVID-19	Total (BRL/USD)
2019	1.800.677.015 BRL	54.927.370.845 BRL	8.418.696 BRL	23.570.810.342 BRL	1.605.000 BRL	2.700.450.193 BRL	ND	**83.009.332.094 BRL (20,8%)**
2020	1.777.275.881 BRL	52.744.007.333 BRL	ND	24.101.034.260 BRL	16.388.028 BRL	2.721.639.487 BRL	30.875.446.859 BRL	**112.235.791.852 BRL (28,2%)**
2021	1.671.375.661 BRL	67.711.618.311 BRL	80.000 BRL	29.868.080.213 BRL	20.000 BRL	2.927.523.420 BRL	1.671.927.680 BRL	**103.850.625.286 BRL (26%)**
2022	1.985.438.667 BRL	61.202.308.378 BRL	205.000 BRL	33.004.188.794 BRL	23.129.968 BRL	3.522.559.727 BRL	ND	**99.737.830.536 BRL (25%)**
Total	**7.234.767.225 BRL** **USD 1,341,072,300** **(1,8%)**	**236.585.304.869 BRL** **USD 43,854,624,358** **(59,3%)**	**8.703.696 BRL** **USD 1,613,360** **(0%)**	**110.544.113.612 BRL** **USD 20,491,004,630** **(27,7%)**	**41.142.997 BRL** **USD 7,626,469** **(0%)**	**11.872.172.829 BRL** **USD 2,200,684,780** **(3%)**	**32.547.374.539 BRL** **USD 6,033,142,612** **(8,2%)**	**398.833.579.769 BRL** **USD 73,929,768,512** **(100%)**

Fonte: FNS, 2024. Acesso em 19 fev. 2024; Nota: ND =Não disponível

Durante o período de 2019 a 2022, no âmbito da Assistência Farmacêutica e considerando o bloco de Custeio, foram observadas as seguintes alocações de recursos: A Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na APS recebeu um total de 5.180.053.762,00 BRL (USD 960,200,431.78), enquanto para a Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS foram destinados 224.880.000,00 BRL (USD 41,684,871.04). Adicionalmente, 1.809.852.968,00 BRL (USD 335,483,313.72) foram repassados para o Apoio Financeiro na Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, e o Programa de Apoio ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS recebeu 19.980.494 BRL (USD 3,703,683.36). Observou-se um acumulado de 7.234.767.225 BRL (USD 1,341,072,300.11) para a Assistência Farmacêutica, a partir dos registros do FNS, conforme apresentado no quadro 2. Ressalta-se ainda que a Assistência Farmacêutica representou 1,81% dos recursos repassados pelo FNS, e outras áreas também contemplaram este bloco sendo estas Atenção Especializada (0,02%), Atenção Primária (27,72%), Gestão do SUS (0,01%), para Vigilância em Saúde (2,98%), Média e Alta Complexidade (59,32%) e COVID-19 (8,16%).

Quadro 2: Transferência de Recursos para a área de Assistência Farmacêutica no Brasil no período de 2019 a 2022, advindas do FNS, e associados ao Bloco de Custeio

Ano	Promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atenção primária em saúde.	Organização dos serviços de assistência farmacêutica no SUS.	Apoio financeiro para aquisição e distribuição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica.	Apoio ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS.	Total (R$)
2019	1.177.981.064 BRL	45.726.000 BRL	570.469.950 BRL	6.500.000 BRL	**1.800.677.015 BRL (24,9%)**
2020	1.262.821.944 BRL	77.292.000 BRL	430.661.937 BRL	6.500.000 BRL	**1.777.275.881 BRL (24,6%)**
2021	1.278.187.323 BRL	50.916.000 BRL	338.572.337 BRL	3.700.000 BRL	**1.671.375.661 BRL (23,1%)**
2022	1.461.063.429 BRL	50.946.000 BRL	470.148.743 BRL	3.280.494 BRL	**1.985.438.667 BRL (27,4%)**
Total	**5.180.053.762 BRL** **USD 960,200,431** **(71,6%)**	**224.880.000 BRL** **USD 41,684,871** **(3,1%)**	**1.809.852.968 BRL** **USD 335,483,313** **(25%)**	**19.980.494 BRL** **USD 3,703,683** **(0,3%)**	**7.234.767.225 BRL** **USD 1,341,072,300** **(100%)**

Fonte: FNS, 2024. Acesso em 20 fev. 2024

Após análise dos dados coletados, advindos do FNS referente aos registros associados à Média e Alta Complexidade, envolvendo o bloco de Custeio, verificou-se que para esta área foram destinados 236.585.304.869,00 BRL (43,854,624,358.66 USD), o que representou 59,3% dos recursos encaminhados ao bloco de Custeio, no período de 2019 a 2022. Além disso, foram alocados 367.915.981 BRL (USD 68,198,729.21) para o Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde, e 211.273.665.353 BRL (USD 39,162,733,442.22) para a Atenção à Saúde da População em Procedimentos na MAC. Outros investimentos incluíram 198.000 BRL (USD 36,702.26) destinados à Estruturação da Atenção Especializada em Saúde Mental, 2.913.450 BRL (USD 540,051.52) para a Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde, e 17.416.104.115 BRL (USD 3,228,335,353.19) para o Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento das Metas (Nível nacional). Ademais, foram direcionados 52.320.000 BRL (USD 9,698,294.43) para a Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), e 7.472.187.969 BRL (USD 1,385,081,785.61) destinados ao Enfrentamento da Emergência de Saúde.

Quadro 3: Ações do Bloco de Custeio direcionadas às ações de Média e Alta Complexidade, advindos do FNS, no período de 2019 a 2022 no Brasil

Ano	Apoio a manutenção de unidades de saúde	Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC.	Estruturação da atenção especializada em saúde mental	Implementação da regulação, controle e avaliação da atenção à saúde	Incremento temporário ao Custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento das metas – nacional	Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	Enfrentamento da emergência de saúde*	Total (BRL/USD)
2019	349.395.009 BRL	49.690.619.478 BRL	198.000 BRL	2.898.450 BRL	4.871.179.908 BRL	13.080.000 BRL	ND	**54.927.370.845 BRL (23,22%)**
2020	9.343.350 BRL	50.112.417.265 BRL	ND	ND	2.609.166.718 BRL	13.080.000 BRL	ND	**52.744.007.333 BRL (22,29%)**
2021	9.177.622 BRL	55.773.781.130 BRL	ND	15.000	4.539.664.589 BRL	13.080.000 BRL	7.375.899.969 BRL	**67.711.618.311 BRL (28,62%)**
2022	ND	55.696.847.478 BRL	ND	ND	5.396.092.900 BRL	13.080.000 BRL	96.288.000 BRL	**61.202.308.378 BRL (25,87%)**
Total	**367.915.981 BRL** **USD 68,198,729 (0,16%)**	**211.273.665.353 BRL** **USD 39,162,733,442 (89,30%)**	**198.000 BRL** **USD 36,702 (0,00%)**	**2.913.450 BRL** **USD 540,051 (0,00%)**	**17.416.104.115 BRL** **USD 3,228,335,353 (7,36%)**	**52.320.000 BRL** **USD 9,698,294 (0,02%)**	**7.472.187.969 BRL** **USD 1,385,081,785 (3,16%)**	**236.585.304.869 BRL** **USD 43,854,624,358 (100,00%)**

Fonte: FNS, 2024. Acesso em 25 fev. 2024 / Nota: ND = Não Disponível / ***(Crédito extraordinário)**

Para a Atenção Especializada foram verificados um total de 8.703.696,83 BRL (USD 1,613,360.37) no período compreendido entre 2019 e 2022. Desses recursos, 8.418.696,83 BRL (USD 1,560,531.35) foram direcionados ao Apoio à Implementação da Rede Cegonha, enquanto 285.000,00 BRL (USD 52,829.01) foram destinados à Implementação de Políticas de Atenção Especializada em Saúde, conforme detalhado no quadro 4.

Quadro 4: Recursos destinados à Atenção Especializada, advindos do FNS, no Bloco de Custeio no período de 2019 a 2022 no Brasil

Ano	Apoio à implementação da rede cegonha	Implementação de políticas de atenção especializada à saúde	Total
2019	8.418.696,83	ND	8.418.696,83 BRL (96,72%)
2020	ND	ND	ND
2021	ND	80.000,00	80.000,00 BRL (0,92%)
2022	ND	205.000,00	205.000,00 BRL (2,35%)
Total	**8.418.696,83 BRL** **USD 1,560,531.35** **(96,72%)**	**285.000,00 BRL** **USD 52,829.01** **(3,27%)**	**8.703.696,83 BRL** **USD 1,613,360.37** **(100%)**

Fonte: FNS, 2024. Acesso em 25 fev. 2024; Nota: ND = Não Disponível

4.3 Distribuição e perfil de alocação dos recursos públicos no Brasil associados ao bloco de Investimento das ações em saúde (2019-2022)

O bloco de investimento representou apenas 7.450.056.151 BRL (USD 1,380,979,322), ou 1,83% dos recursos destinados à saúde, advindos do FNS, durante o período de 2019 a 2022 no Brasil. Para este bloco observa-se que Atenção Primária (43,82%) e Atenção Especializada (35,4%) foram as áreas que mais foram destinados recursos financeiros, conforme apresentado no quadro 5.

Quadro 5: Transferência de recursos públicos para a saúde no Brasil entre 2019 e 2022 no Bloco de Investimento do SUS advindos do FNS

Ano	Assistência Farmacêutica	Atenção Especializada	Atenção Primária	Vigilância em saúde	COVID-19	TOTAL (R$)
2019	1.560.000,00 BRL	416.609.996,38 BRL	1.141.948.630,25 BRL	25.865.578,00 BRL	ND	1.585.984.204,63 BRL 21,29%
2020	44.491.323,95 BRL	949.337.279,84 BRL	534.422.153,33 BRL	59.589.049,80 BRL	1.366.838.778,00 BRL	2.954.678.584,92 BRL 39,66%
2021	1.600.000,00 BRL	670.830.008,00 BRL	830.257.218,51 BRL	13.665.904,00 BRL	24.426.790,00 BRL	1.540.779.920,51 BRL 20,68%
2022	10.367.608,00 BRL	599.793.866,00 BRL	757.808.019,19 BRL	643.948,00 BRL	ND	1.368.613.441,19 BRL 18,37%
Total	**58.018.931,95 BRL** **USD 10.754.676,70** **0,78%**	**2.636.571.150,22 BRL** **USD 488.727.892,25** **35,39%**	**3.264.436.021,28 BRL** **USD 605.112.035,74 43,82%**	**99.764.479,80 BRL** **USD 18.492.838,29** **1,34%**	**1.391.265.568,00 BRL** **USD 257.891.879,21** **18,67%**	**7.450.056.151,25 BRL** **USD 1.380.979.322,21** **100,00%**

Fonte: FNS, 2024. Acesso em 19 fev. 2024; Nota: ND = Não Disponível

No contexto da Atenção Especializada, observou-se um total de 2.636.571.150 BRL (USD 488,727,892.21), considerando o bloco de Investimento. Destes, 9.607.160 BRL (USD 1,780,830.7) foram destinados ao Apoio à Implementação da Rede Cegonha e 12.495.000 BRL (USD 2,316,135.11) foram alocados para a Estruturação da Atenção Especializada em Saúde Mental. Além disso, foram investidos 28.521.931 BRL (USD 5,286,966.45) na Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde e 2.528.638.790 BRL (USD 468,721,015.17) destinados à Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde. Adicionalmente, foram alocados recursos no valor de 42.989.850 BRL (7,968,811.6 USD) para a Estruturação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia. Outros investimentos incluíram 358.417 BRL (USD 66,437.95) destinados à Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde, assim como um aporte de 13.960.000 BRL (USD 2,587,694.76) para o Programa de Implementação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), conforme detalhado no quadro 6.

Quadro 6: Ações do Bloco de Investimento, advindos do FNS, direcionadas à Atenção Especializada no período de 2019 a 2022 no Brasil

Ano	Apoio à implementação da rede cegonha	Estruturação da atenção especializada em saúde mental	Estruturação de serviços de atenção às urgências e emergências na rede assistencial	Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde	Estruturação dos serviços de hemoterapia e hematologia	Implementação da regulação, controle e avaliação da atenção à saúde	Implementação, construção e ampliação de UPA	Total (R$)
2019	7.765.160 BRL	5.000.000 BRL	2.424.765 BRL	376.335.946 BRL	18.147.436 BRL	26.688 BRL	6.910.000 BRL	**416.609.996 BRL 15,80%**
2020	1.842.000 BRL	3.092.000 BRL	8.995.955 BRL	920.104.510 BRL	8.851.084 BRL	331.729 BRL	6.120.000 BRL	**949.337.279 BRL 36,01%**
2021	ND	4.403.000 BRL	2.630.552 BRL	662.716.456 BRL	150.000 BRL	ND	930.000 BRL	**670.830.008 BRL 25,44%**
2022	ND	ND	14.470.659 BRL	569.481.877 BRL	15.841.330 BRL	ND	ND	**599.793.866 BRL 22,75%**
Total	**9.607.160 BRL** **USD 1.780.830 0,36%**	**12.495.000 BRL** **USD 2.316.135 0,47%**	**28.521.931 BRL** **USD 5.286.966 1,08%**	**2.528.638.790 BRL** **USD 468.721.015 95,91%**	**42.989.850 BRL** **USD 7.968.811 1,63%**	**358.417 BRL** **USD 66.437 0,01%**	**13.960.000 BRL** **USD 2.587.694 0,53%**	**2.636.571.150 BRL** **USD 488.727.892 100%**

Fonte: FNS, 2024. Acesso em 19 fev. 2024; Nota: ND = Não Disponível.

5. DISCUSSÃO

O financiamento da saúde no Brasil é uma questão complexa que envolve múltiplos atores e fontes de recursos. O SUS é financiado por meio de uma combinação de recursos públicos e privados, incluindo impostos, contribuições sociais, taxas e repasses da União, dos estados e dos municípios, e nas últimas décadas, o sistema tem enfrentado desafios significativos relacionados à insuficiência de recursos e, infelizmente, à má gestão dos serviços de saúde nas diferentes esferas de governo (união, estado e município) (Cashin et al., 2017). Neste contexto, observou-se a partir dos resultados deste estudo, quase a totalidade das transferências de recursos para a saúde (406.283.635.920,00 BRL/USD 75,310,747,834.5), advindas do FNS, foram destinados para o bloco de custeio 398.833.579.769 BRL/USD 73,929,768 (98%), quando comparado com apenas 7.450.056.151 BRL/USD 1,380,979,322 (1,83%) do bloco de investimento. Os nossos resultados corroboram com alguns estudos que revelam que, em geral, o Brasil direciona poucos recursos para a área de investimentos em saúde. Esse aspecto pode ser considerado um reflexo da Emenda Constitucional 95 (BRASIL, 2016) que instaurou no Brasil um novo regime fiscal, que sob a égide da austeridade, inviabilizou a ampliação de novos recursos públicos federais para a saúde, agravando o quadro histórico de subfinanciamento já existente no país.

Uma das principais questões relacionadas ao financiamento da saúde no Brasil é a distribuição desigual de recursos entre as diferentes regiões e níveis de atenção à saúde. Historicamente, as regiões mais ricas do país tendem a receber uma parcela maior dos recursos, enquanto as regiões mais pobres enfrentam uma escassez crônica de financiamento e infraestrutura (Louvison, 2019). Como podemos observar na Figura 1, a região Sudeste representou um percentual de 44,7% com um valor de 3.262.537.243,96 BRL (USD 604,760,068.97), destinado à Assistência Farmacêutica, quantia muito superior ao encontrado para a região Norte, o qual foram destinados 520.600.431,86 BRL (USD 96,501,075.55), o que totalizou apenas 7,1%. Aspectos como estes podem acarretar em disparidades significativas no acesso aos serviços de saúde e na qualidade do atendimento, contribuindo para a perpetuação crônica das desigualdades sociais e de saúde no país. Ainda neste cenário, segundo um estudo realizado pela Rede de Colaboradores do Financiamento da Saúde Global (2021), a distribuição desigual de recursos pode ser verificada em diversas partes do mundo. Pondera-se, entretanto, que, do ponto de vista da economia de escala, serviços de maiores densidades tecnológicas tendem a ser mais concentrados em territórios de maior porte populacional (BRASIL, 2022b).

A partir dos resultados apresentados, obtidos no FNS, verificou-se que os recursos destinados à área da saúde no Brasil, no período de 2019 a 2022, foi de 406.283.635.920,00 BRL (USD 75,310,747,834.5) e observa-se a diferença orçamentária aplicada a área da Média e Alta Complexidade, que comprometeu 59,32% dos recursos destinados à saúde, quando avaliada dentre os valores destinados ao Bloco de Custeio. Destacam-se que as demais áreas APS (27,72%), Vigilância em Saúde (2,98%) e Assistência Farmacêutica (1,81%) representaram um percentual muito inferior quando comparado ao percentual de recursos destinados à área anteriormente citada. Os resultados deste estudo corroboram as observações de outros autores na literatura, que registram a subvalorização da APS, que historicamente tem recebido recursos financeiros muito inferiores quando comparada a níveis de maior complexidade (Brundtland, 2022; Debie et al., 2024). Outra possibilidade nesse sentido é o fato de que o setor da média e alta complexidade abrange procedimentos que requerem o manejo de tecnologia de ponta, e consequentemente alcançam valores de custos mais elevados (BRASIL, 2022a).

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 85% dos problemas de saúde da população podem ser resolvidos nas unidades básicas de saúde ou centros de saúde, sendo de extrema relevância ao SUS (BRASIL, 2019), mesmo recebendo uma diferença considerável de recursos comparado a Média e Alta Complexidade. No que tange ao período da pandemia de COVID-19, Giovanella et al (2020) afirmam que o enfrentamento dos países foi condicionado, além do contexto e da política local, pelo modo como a APS foi organizada e inserida dentro dos sistemas de saúde, o que mostra a essencialidade do papel desse nível de atenção para capacidade de resposta dos sistemas nacionais de saúde de modo geral.

A análise do financiamento revela que a média e alta complexidade recebeu um investimento de 236.585.304.869 BRL (USD 43,854,624,358.66), enquanto a atenção primária foi contemplada com 110.544.113.612 BRL (USD 20,491,004,630.23), isto evidencia uma disparidade significativa na alocação de recursos. Estudos como os de Stange et al. (2023) e Brundtland (2022) indicam que essa diferença reflete a priorização de tratamentos mais complexos e de maior custo, como internações hospitalares e procedimentos especializados, em detrimento da APS, que é fundamental para a prevenção e o manejo inicial de doenças. Isso mostra que, apesar da APS ser o pilar do sistema de saúde, sendo essencial para a promoção da saúde e prevenção de doenças, frequentemente recebe menos recursos, o que pode comprometer sua eficácia e a capacidade de reduzir a demanda por serviços de alta complexidade. Adicionalmente, observam-se que outros países como Canadá e Reino Unido tem demonstrado uma maior valorização da APS, através do forte enfoque na clínica e no indivíduo com o auxílio de profissionais de saúde como os médicos de família e enfermeiras com formação avançada (Brandão, 2019).

Considerando o valor destinado à saúde, advindos do FNS, do período de 2019 a 2022 de 406.283.635.921 BRL (USD 75,310,747,834), verifica-se que o Brasil mesmo tendo a saúde como um direito constitucional ao cidadão e devendo ofertar serviços dos diferentes tipos de níveis de complexidade a mais de 200 milhões de brasileiros, ainda destina um percentual inferior do seu PIB para as ações em saúde. Ainda assim, a partir de dados obtidos em uma pesquisa publicada por Cabral, 2020 mostra que os gastos com saúde no Brasil, como proporção do PIB, são semelhantes à média (8,8%) de países selecionados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mesmo que abaixo da participação de alguns países como França (11,1%) e Reino Unido (10,2%). Já o percentual do PIB destinado à saúde pública no Brasil (3,8%) é menor do que o da maioria dos países selecionados, ficando acima apenas do México, que destina 2,7% do seu PIB para essa área. De acordo com a publicação "Painel – Saúde em números", elaborada pelo Núcleo de Estudos e Análises da Anahp (NEA), as despesas com saúde no Brasil, no ano de 2022, atingiram cerca de 914,85 bilhões de reais (USD 169,581,128,957.8) o que corresponde a 9,23% do PIB Brasileiro (Anahp, 2023; OECD, 2024).

Segundo Souza e colaboradores (2024), em estudo que avaliou as percepções dos usuários do SUS sobre aspectos como acesso e qualidade dos serviços públicos de saúde, da Região da Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro, demonstrou que para 97,5% dos entrevistados (n=195), a vacinação é o serviço mais utilizado do SUS pelos participantes, incluindo tanto aqueles que tinham ou não plano de saúde privado. Neste estudo foi demonstrado algumas percepções sobre fragilidades e demandas em saúde como a necessidade de melhorias em infra-estrutura e a dificuldade de atendimentos com consultas com especialistas, em especial, o brasileiro que vive em municípios no interior do país, o qual não se a praticidade e fácil acesso a serviços como realização de cirurgias. A partir dos resultados citados juntamente com os resultados deste estudo, o qual o bloco de Investimento recebeu apenas 1,83% dos recursos destinados do FNS, observam-se que o país não transferidos muitos recursos ao bloco de Investimento, sendo também algo a ser avaliado e passível de ser aprimorado para melhor atender as demandas da população.

O período deste estudo contempla a pandemia associada ao *SARS-CoV-2*, o que representou para o Brasil mais de 30 milhões de infectados e 700 mil óbitos em decorrência deste vírus. Dados do Ministério da Saúde revelam que mais de 540 bilhões de reais (USD 100,097,075,626.886) foram gastos associados com os serviços e ações realizadas pelo governo em combate e controle desta pandemia (Brasil, 2022; Brasil, 2024). Dados do Tribunal de Contas da União revelaram, que a pandemia de COVID-19 custou 597,6 bilhões de reais (USD 110,774,097,027.06) aos cofres do governo federal, até o dia 18 de agosto de

2021, sendo 63,2 bilhões de reais (USD 11,715,065,147.44) com à operacionalização e o custeio do Programa Auxílio Emergencial, 47,7 bilhões (USD 8,841,908,347.03) com o financiamento de ações na área de saúde e, pelo menos, 38 bilhões (USD 7,043,868,284.85) foram destinados à aquisição de mais de 650 milhões de doses de vacinas (Tribunal De Contas Da União, 2021; Brasil, 2022). Em revisão sistemática publicada em 2023, foi demonstrado que a introdução de vacinas COVID-19 e tratamentos ambulatoriais teve um impacto positivo significativo no uso dos recursos de saúde nos EUA. Especificamente, a vacina de reforço foi associada a uma redução de aproximadamente 81% no risco de hospitalização por COVID-19. Além disso, o tratamento ambulatorial foi associado a uma redução de até 72% no risco de hospitalização em comparação com a ausência de tratamento (Pierre et al., 2023).

Adicionalmente, Bigoni et al.(2022) registram sobre a má gestão dos serviços de saúde no país, que passou por surtos anteriores, como por exemplo o de Influenza em 2009 e Zika em 2015, nessas duas ocasiões as ações do sistema de saúde foram de extrema importância para que as epidemias fossem controladas. A coordenação nacional do SUS, concomitante às intervenções locais realizadas pelas equipes de saúde pública e de APS dos governos municipais, desempenharam um papel fundamental nessas respostas. Porém, a partir de 2015, a capacidade do SUS vem sendo enfraquecida por fatores econômicos e políticos. Segundo Funcia et al. (2020) dos 39 bilhões de reais (USD 7,229,233,239.71) disponíveis para o enfrentamento da COVID-19 pelo MS, a maior parte estava sem uso no orçamento até 30 de junho de 2021, sendo 73,5% para aplicação direta do MS, 65,6% para transferência financeira aos municípios e 58,7% para transferência financeira aos estados e Distrito Federal. Em outras palavras, os autores destacaram problemas de gestão que podem ter impactado e levado a desdobramentos graves para o país no período da pandemia.

Neste período, o Brasil investiu significativamente em vacinação, com o Ministério da Saúde destinando mais de 38 bilhões de reais (USD 7,043,868,284.85) para a aquisição de vacinas. O Programa Nacional de Imunizações (PNI), um dos maiores e mais reconhecidos programas de vacinação do mundo, foi crucial nesse esforço, distribuindo mais de 650 milhões de doses de vacinas para a população (Brasil, 2022). Os gastos totais com a pandemia ultrapassaram 540 bilhões de reais (USD 100,097,075,626.86), incluindo investimentos em leitos de UTI e medicamentos, o que pode ter acarretado o aumento de gastos na atenção especializada. Esse esforço massivo ajudou a reduzir a taxa de hospitalizações e óbitos, demonstrando a importância do PNI na saúde pública brasileira. Ao longo dos anos, diversos estudos têm sido realizados para analisar e propor soluções para os desafios enfrentados pelo sistema de saúde brasileiro em relação ao financiamento. Um desses estudos, realizado por

Fernandes e Pereira (2020), destaca a importância de promover uma maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis, identificando áreas de desperdício e implementando medidas para reduzir custos sem comprometer a qualidade dos serviços de saúde. Assim como demonstrado no estudo de Tekola et al. (2017), investir em vigilância em saúde é crucial para detectar, prevenir e responder a emergências de saúde pública. Essa abordagem reduz o impacto de epidemias, como o caso de uma nova doença.

Dentre as limitações observadas neste estudo, destaca-se a dificuldade de extrair alguns dados e a escassez de estudos prévios no período analisado, o que dificultou, em especial, a comparabilidade dos resultados encontrados com outros estudos nacionais. Além disso, houve falta de alguns dados em sites do governo, o que pode causar ao leitor um viés de variável omitida. Apesar das dificuldades encontradas, ressalta-se que é um estudo que visa contribuir com dados econômicos e reflexões importantes para o cenário da saúde pública de um país continental com inúmeras particularidades e demandas e marcado por restrições orçamentárias.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste estudo pode-se verificar que 406.283.635.920,00 BRL (USD 75,310,747,834.5) foram destinados à saúde envolvendo o Bloco de Custeio (398.833.579.769 BRL/USD 73,929,768,512.3) e o Bloco de Investimento (7.450.056.151,25 BRL/USD 1,380,979,322.21), advindo do FNS, para o período entre 2019 a 2022. Dados que demonstram o perfil e proporção das transferências de recursos públicos direcionados às ações de custeio dos serviços e ações em saúde de um período que desafiou o cenário da gestão pública com o aumento das demandas em saúde, as quais possivelmente dificultaram que mais verbas públicas fossem destinadas às ações de investimento em saúde no Brasil. Adicionalmente, observou-se dentro do Bloco de Custeio e percentual bem superior de recursos transferidos para a área de Média e Alta Complexidade (59,32%) comparado com o de outras áreas como da APS (27,72%), Assistência Farmacêutica (1,8%) e Vigilância Sanitária (2,9%), panorama este que pode estar associado diretamente com o aumento deste tipo de demanda, em especial, durante a pandemia de SARS-CoV-2 e/ou por ser um perfil nacional de direcionar de modo desproporcional mais recursos a esta área comparado a outras como a APS. Ressalta-se que durante o período da pandemia de SARS-CoV-2, mais de 540 bilhões de reais foram gastos com o enfrentamento à pandemia, incluindo a compra de vacinas e o Programa Auxílio Emergencial.

Ressalta-se a importância da compreensão do perfil da alocação e das transferências de recursos públicos, advindos do FNS, em um país como o Brasil com tantas demandas e particularidades, com um cenário de restrições orçamentárias. A relevância de ser avaliados outros períodos e em diferentes gestões da esfera federal que possibilitem a rastreabilidade de dados, para uma melhor análise e discussão dos avanços e perfis de distribuição referente a alocação dos recursos públicos em saúde. Destaca-se que a universalidade e a integralidade são princípios norteadores a serem adotados para uma gestão pública eficiente e racional com foco no atendimento das reais demandas da população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEGRE, J. C.; SHARMA, Suneeta; CLEGHORN, Farley; AVILA, Carlos. Strengthening primary health care in low- and middle-income countries: furthering structural changes in the post-pandemic era. Frontiers in Public Health, [S.l.], v. 11, 2024. DOI: 10.3389/fpubh.2023.1270510. ISSN 2296-2565.

ANAHp. Painel 2023 - Saúde em Números. Disponível em: https://www.anahp.com.br/painel-2023-saude-em-numeros. Acesso em: 29 jul. 2024.

ANDERSON, M.; PITCHFORTH, E.; EDWARDS, N.; ALDERWICK, H.; McGUIRE, A.; MOSSIALOS, E. United Kingdom: Health System Review. Health systems in transition, v. 24, n. 1, p. 1-194, 2022.

ANDRADE, S. M.; SANTOS, R. T. Desafios Na Distribuição De Recursos Financeiros Federais e a Mudança Do Modelo De Cofinanciamento Federal Da Atenção Primária À Saúde. JMPHC | Journal of Management & Primary Health Care, [S. l.], v. 14, n. spec, p. 037, 2022.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes. Acesso em: 19 ago. 2024.

BANCO MUNDIAL. Paridades de Poder de Compra (PPPs). 2021. Disponível em: https://www.worldbank.org. Acesso em: 04 ago. 2024

BIGONI, Alessandro et al. Funcionalidade do sistema de saúde brasileiro em meio à pandemia de COVID-19: uma análise da resiliência. The Lancet Regional Health – Américas, v. 10, p. 100222, 2024.

BORTOLI, Maritsa Carla; SANINE, Patricia Rodrigues; ARAÚJO, Bruna Carolina de; OLIVEIRA, Cintia de Freitas; COSTA, Maria Izabel Sanches; TESSER, Taís Rodrigues. Estratégias dos serviços de Atenção Primária durante a pandemia da COVID-19 no Brasil:

uma revisão de escopo. Ciênc. saúde coletiva, v. 28, n. 12, p. 3427-3437, 2023. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/csc/2023.v28n12/3427-3437/. Acesso em: 18 jul. 2024.
BRANDÃO, J. R. M. Primary Health Care In Canada: Current Reality And Challenges. Cadernos de Saúde Pública, v. 35, n. 1, p. e00178217, 2019.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil [Internet]. Brasília, DF: Senado Federal; 2016 [acesso em: 20 fev. 2024]. 496 p. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. Lei n°. 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção Primária à Saúde. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/atencao-primaria. Acesso em: 18 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Regulação Assistencial e Controle. Curso I: Regulação de Sistemas de Saúde do SUS: módulo 4: Redes de Atenção à Saúde [recurso eletrônico]. 1. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2022b. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo4_regulacao_redes_atencao_saude.pdf. Acesso em: 29 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção Primária e Atenção Especializada: Conheça os níveis de assistência do maior sistema público de saúde do mundo, 2022. Disponível em: Atenção Primária e Atenção Especializada: Conheça os níveis de assistência do maior sistema público de saúde do mundo — Ministério da Saúde. Acesso em: 18 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundo Nacional de Saúde. Portal da Saúde, 2024. Disponível em: https://www.saude.gov.br/fns. Acesso em: 18 jul. 2024.

BRASIL. Plano Plurianual, 2020-2023. Disponível em: <https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/planejamento/plano-plurianual/paginas/ppa- 2020-2023>. Acesso em: 09 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunizações, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/pni. Acesso em: 22 jul. 2024.

BRUNDTLAND, Gro Harlem. Public financing for primary health care is the key to universal health coverage and strengthening health security. The Lancet Global Health, [S.l.], v. 10, n. 5, p. e715-e716, abr. 2022. DOI: 10.1016/S2214-109X(22)00166-8.

CABRAL, Umberlândia. Despesas com saúde no Brasil atingem R$711,4 bilhões em 2019. IBGE, 14 out. 2020. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/33484-despesas-com-saude-em-2019-representam-9-6-do-pib. Acesso em: 31 out. 2024.

CARDOSO, A. A. B.; REIS, A. O.; DE CASTRO, E. L.; REIS, V. O. Eficiência Na Alocação Dos Recursos Públicos Na Área De Saúde: Análise Dos Municípios De Minas Gerais. Revista Cereus, v. 9, n. 1, p. 18-36, 2017.

CASHIN, Cheryl et al. Aligning Public Financial Management and Health Financing: Sustaining Progress Toward Universal Health Coverage. Geneva: World Health Organization, 2017. (Health Financing Working Paper; No. 4). Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254680/1/9789241512039-eng.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

CASTRO, M. C.; MASSUDA, A.; ALMEIDA, G. et al. Brazil's unified health system: the first 30 years and prospects for the future. The Lancet. Publicado online em 11 de julho de 2019. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31243-7. Acesso em: 16 jun. 2024.

CHARLESWORTH, A.; ANDERSON, M.; DONALDSON, C.; JOHNSON, P.; KNAPP, M.; McGUIRE, A.; McKEE, M.; MOSSIALOS, E.; SMITH, P.; STREET, A.; WOODS, M. What is the right level of spending needed for health and care in the UK?. Lancet (London, England), v. 397, n. 10288, p. 2012-2022, 2021. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00230-0.

COELHO, T. C. B.; REGIS, J. M. B.; TELES, A. S.; FERREIRA, M. P. S.; NOVAIS, G. B. A. Involução Do Financiamento Da Saúde: Explorando Dados Geográficos Regionais. JMPHC | Journal of Management & Primary Health Care, [S. l.], v. 11, 2019

COLLOR, Alexandre Ávila. Emenda constitucional nº 95/2016: análise histórica e constitucional e suas consequências no financiamento à saúde. 2023.

COURI, Joseane Rotatori. Os impasses no financiamento do Sistema Único de Saúde na era da mundialização do capital. 2021.

CROZATTI, Jaime et al. O gasto e as fontes do financiamento do SUS nos municípios brasileiros de 2003 a 2018. REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL-Universidade Federal do Rio Grande do Norte-ISSN 2176-9036, v. 12, n. 2, p. 200-218, 2020.

DE ARRUDA PEDROSA, Kamyla et al. Necessidade de reconfiguração do financiamento do SUS diante da austeridade: uma revisão narrativa. Research, Society and Development, v. 11, n. 5, p. e8711527785-e8711527785, 2022.

DEBIE, A.; NIGUSIE, A.; GEDLE, D.; KHATRI, R. B.; ASSEFA, Y. Building a resilient health system for universal health coverage and health security: a systematic review. Glob Health Res Policy, v. 9, n. 1, art. 2, 4 jan. 2024. DOI: 10.1186/s41256-023-00340-z. PMID: 38173020; PMCID: PMC10765832.

DEGUTIS, L. C.; SHOAF, K.; ARAGÓN, T. J.; ATCHISON, C.; DYJACK, D.; HITES, L.; LINKS, J.; OLSON, D.; POTTER, M.; THOMPSON, J.; TURNOCK, B. The Urgent Need for Public Health Preparedness Funding and Support. Revista Brasileira de Saúde Pública, v. 111, n. 3, p. 363-365, 2021. DOI: 10.2105/AJPH.2020.306068. PMID: 33566658; PMCID: PMC7893347.

DOMINGUES, C. M. A. S.; MARANHÃO, A. G. K.; TEIXEIRA, A. M.; FANTINATO, F. F. S.; DOMINGUES, R. A. S. The Brazilian National Immunization Program: 46 years of achievements and challenges. Cad Saude Publica, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311X00222919. Acesso em: 22 jul. 2024.

DWECK, Esther; MORETTI, Bruno; MELO, M. F. G. C. Pandemia e desafios estruturais do CEIS: financiamento do SUS, federalismo da saúde e as relações público-privadas. Cad. Desenv, v. 16, n. 28, p. 239-265, 2021.

EVANGELISTA, S. L.; SODRÉ, F. Participação Do Ministério Da Saúde Nos Gastos Públicos De Enfrentamento a COVID-19 no estado do Espírito Santo, Brasil. JMPHC |

Journal of Management & Primary Health Care, [S. l.], v. 15, n. spec, p. e026, 2023.

FERNANDES, Gustavo Andrey de Almeida Lopes; PEREIRA, Blenda Leite Saturnino. Os desafios do financiamento do enfrentamento à COVID-19 no SUS dentro do pacto federativo. Revista de Administração Pública, v. 54, p. 595-613, 2020.

FUNCIA, F.; BENEVIDES, R.; OCKÉ-REIS. Análise Do Financiamento Federal Do Sistema Único De Saúde Para O Enfrentamento Da COVID-19. Saúde em Debate, v. 46, n. 133, p. 263-276.

FUNCIA, F.; BENEVIDES, R.; OCKÉ-REIS. Boletim Cofin/CNS 2020/06/30. Brasília, DF: Conselho Nacional de Saúde, 2020.

GARCIA, P. L. Thank you Brazilian National Health System. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 54, p. 24, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1679-49742020000500024.Acesso em: 17 jun. 2024.

GIOVANELLA, Lígia; et al. A contribuição da Atenção Primária à Saúde na rede SUS de enfrentamento à Covid-19. Saúde em Debate, v. 44, n. 1, p. 80-92, 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-11042020E410. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/LTxtLz5prtrLwWLzNJZfQRy/#. Acesso em: 29 out. 2024.

Global Burden of Disease 2020 Health Financing Collaborator Network. Tracking development assistance for health and for COVID-19: a review of development assistance, government, out-of-pocket, and other private spending on health for 204 countries and territories, 1990-2050. Lancet, v. 398, n. 10308, p. 1317-1343, 2021. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01258-7. Epub 2021 Sep 22. PMID: 34562388; PMCID: PMC8457757.

GONÇALVES, F. M.; ILHA, S. A.; SODRÉ, F. O Gasto Público Municipal Com Ações E Serviços De Saúde: Um Olhar Para A Atenção Básica. JMPHC | Journal of Management & Primary Health Care, [S. l.], v. 14, n. spec, p. e005, 2022.

GOVERNO DO BRASIL. Bons resultados dos indicadores brasileiros mostram que o Brasil avança na retomada econômica. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/exportacoes-do-agronegocio-fecham-2022-com-us-159-bilhoes-em-vendas Acesso em: 12 mar. 2024.

HASELL, Joe. Which countries have protected both health and the economy in the pandemic? Publicado online em OurWorldInData.org, 2020. Disponível em: https://ourworldindata.org. Acesso em: 19 jun. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php. Acesso em: 8 mar. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Divulgação trimestral. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php. Acesso em: 8 mar. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produto Interno Bruto - PIB. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em: 8 mar. 2024.
IPEADATA. Disponível em: http://ipeadata.gov.br/Default.aspx. Acesso em: 8 mar. 2024.

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY. Coronavirus Resource Center. Disponível em: https://coronavirus.jhu.edu/region/brazil. Acesso em: 30 set. 2024.

LOUVISON, M. C. P. Regionalização dos sistemas de saúde como resposta às desigualdades territoriais: um debate necessário. Cadernos de Saúde Pública, v. 35, p. e00116019, 2019.

MARCHILDON, G. P.; ALLIN, S.; MERKUR, S. Canada: Health System Review. Health systems in transition, v. 22, n. 3, p. 1-194, 2020.

MARQUE, G. F.; SCALON, I.; ALVES, F. N.; CAMPOS, E. M.; PINHEIRO, C. L.; CRISTIAN, S. H. Analisando a Alocação de Recursos em Saúde no Município de Itumbiara. Revista Master - Ensino, Pesquisa e Extensão, [S. l.], v. 8, n. 15, 2023.

MENEZES, Ana Paula do Rego; MORETTI, Bruno; REIS, Ademar Arthur Chioro dos Reis. O futuro do SUS: impactos das reformas neoliberais na saúde pública – austeridade versus universalidade. Saúde debate, Dez 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/JLN5qfhCmLh4ZwY4sm4KWPt/. Acesso em: 6 jan. 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Governo Federal investiu mais de R$ 540 bilhões para o enfrentamento da pandemia no Brasil. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-investiu-mais-de-r-540-bilhoes-para-o-enfrentamento-da-pandemia-no-brasil. Acesso em: 01 out. 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Datasus, 2024. Disponível em: http://siops.datasus.gov.br/. Acesso em: 09 out. 2024.

MORIMOTO, T.; COSTA, J. S. D. Análise Descritiva Dos Gastos Com Internações Por Condições Sensíveis À Atenção Primária. Cadernos Saúde Coletiva, v. 27, n. 3, p. 295–300, 2019.

NATALIA, S.; DE SOUZA, S. D. M.; FERNANDES, D. S. J.; REIS, S. R.; PIASSI, D. G. I. Alocação De Recursos Públicos Para Saúde Em Macaé Entre 2014 E 2017: Reflexões E Desafios. Jornal De Assistência Farmacêutica E Farmacoeconomia, [S. l.], v. 9, n. 2, 2024. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Disponível em: https://www.oecd.org. Acesso em: 29 jul. 2024.

NATALIA, S.; DE SOUZA, S. D. M.; FERNANDES, D. S. J.; REIS, S. R.; PIASSI, D. G. I. Alocação De Recursos Públicos Para Saúde Em Macaé Entre 2014 E 2017: Reflexões E Desafios. Jornal De Assistência Farmacêutica E Farmacoeconomia, [S. l.], v. 9, n. 2, 2024. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Disponível em: https://www.oecd.org. Acesso em: 29 jul. 2024.

PAIM, J. S.; SILVA, L. M. V. Universalidade, integralidade, equidade e SUS. BIS, Bol Inst Saúde, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 109-114, ago. 2010. Disponível em: http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1518-18122010000200002&lng=pt&nrm=iso3. Acesso em: 17 jun. 2020.

PEREIRA, B. L. S.; OLIVEIRA JUNIOR, A. C. R.; FALEIROS, D. R. Portaria 3992/2017: desafios e avanços para gestão dos recursos no Sistema Único de Saúde. Revista de Saúde Pública, v. 53, p. 58, 2019.

Planalto. Lei Nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14116.htm. Acesso em: 28 set. 2024

SERVO, Luciana Mendes Santos et al. Financiamento do SUS e Covid-19: histórico, participações federativas e respostas à pandemia. Saúde em Debate, v. 44, p. 114-129, 2021.

SOARES, A.; SANTOS, N. R. Financiamento Do Sistema Único De Saúde Nos Governos Fhc, Lula E Dilma. Saúde em Debate, v. 38, n. 100, p. 18–25, 2014.

STANGE, K. C.; MILLER, W. L.; ETZ, R. S. The Role of Primary Care in Improving Population Health. The Milbank Quarterly, v. 101, n. S1, p. 795–840, 2023.

SOUZA JS, REIS EA, GODMAN B, CAMPBELL SM, MEYER JC, SENA LWP, GODÓI IPD. Users Perseptions of Acess to and Quality of Unifield Health System Services in Brazil: A Cross-Sectional Study and Implications to Healthcare Management Challenges. Int J. Environ. Res. Public Health [internet] 21(6)721, 2024. Acesso em: 18 ago 2024.

TEKOLA, B.; MYERS, L.; LUBROTH, J.; PLEE, L.; CALISTRI, P.; PINTO, J. International health threats and global early warning and response mechanisms. Rev Sci Tech., v. 36, n. 2, p. 657-670, ago. 2017. DOI: 10.20506/rst.36.2.2683. PMID: 30152454.

VIANA, Larissa; SILVA, Gabriel; GODÓI, Isabella. Financiamento da saúde pública no estado do Rio de Janeiro: panorama (2019-2022), desafios e reflexões. Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, v. 9, n. 4, p. 33-46, out. 2024.